

TEMA 1.9 • PEDIATRÍA

Fiebre en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.1.017

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Fiebre en Pediatría

Definición

Fiebre: temperatura $\geq 38^{\circ}\text{C}$ por cualquier vía (se recomienda vía rectal por ser la más precisa).

Hipotermia: temperatura $< 35^{\circ}\text{C}$ (medir por vía rectal para confirmar).

Causas

- **Viral:** la más frecuente en pediatría (la gran mayoría de las fiebre sin foco)
- **Bacteriana:** menos frecuente pero más grave. Focos más importantes:
 1. Infección urinaria / pielonefritis aguda (la más frecuente)
 2. Neumonía bacteriana
 3. Meningitis bacteriana aguda
 4. Sepsis

Tratamiento Sintomático

- **Paracetamol (acetaminofeno):** 10–15 mg/kg/dosis, máximo cada 6 horas (máx. 4 dosis/día)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los **AINEs** están contraindicados en lactantes < 1 año (riesgo de insuficiencia renal y sangrado gastrointestinal). En > 1 año pueden usarse con precaución.

Manejo de Fiebre Sin Foco Según Edad

< 4 semanas (Recién Nacido)

Manejo completo → igual que sepsis: - Todos los exámenes: hemograma, hemocultivos, sedimento orina + urocultivo, Rx tórax, **punción lumbar** - **Antibióticos empíricos inmediatos:** Ampicilina + Cefotaxima (o Ampí + Gentamicina) - Hospitalización obligatoria

4–6 semanas

- Mismos exámenes que el RN **sin punción lumbar** - Antibióticos a la espera de resultados (mismo esquema)

6 semanas – 3 meses

- Mismos exámenes sin PL - **Sin antibióticos** si aspecto no tóxico → esperar resultados - Control en 24–48 horas

3 meses – 1 año

- Sin exámenes si temperatura $< 39^{\circ}\text{C}$ y buen aspecto general - Solo paracetamol + observación + control en 24–48 horas - Si $T^{\circ} \geq 39^{\circ}\text{C}$: descartar foco urinario → sedimento orina + urocultivo

> 1 año

- Paracetamol + observación - Control en 1–2 días - Sin exámenes en la mayoría de los casos

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla práctica: A menor edad, más agresivo el estudio. El RN con fiebre = sepsis hasta demostrar lo contrario → hospitalizar + antibióticos siempre.

Manejo del Niño con Aspecto Tóxico (Cualquier Edad)

- Si el niño viene **comprometido, séptico, con aspecto tóxico** (independiente de la edad):

- Todos los exámenes + **punción lumbar**
- **Antibióticos inmediatos:**
 - Si > 6 semanas: **Ceftriaxona** (cubre meningitis, neumonía, pielonefritis) + **Vancomicina** (cubre neumococo resistente)

Interpretación de Resultados

TABLA 1.9.1: HALLAZGO VS CONDUCTA

HALLAZGO	CONDUCTA
Hemocultivo positivo	Completar estudio + antibióticos dirigidos
Hemograma con > 20.000 leucocitos con neutrofilia	Completar estudio + antibióticos empíricos
Aspecto tóxico / séptico	Manejo completo (exámenes + PL + ATB)

Hipotermia ($T^{\circ} < 35^{\circ}\text{C}$)

- **Causas:**
 - Exposición al frío (más frecuente)
 - Iatrogénica (exceso de medidas antitérmicas)
- En RN: **sepsis** (la hipotermia en RN = sepsis hasta demostrar lo contrario, igual que la fiebre)
- **Tratamiento:**
 - Retirar del frío, abrigar
 - Lactante: contacto piel a piel con los padres o incubadora
 - Leve-moderada: líquidos calientes vía oral
 - Grave: líquidos tibios **endovenosos**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 22 días consulta por fiebre de 38.2°C rectal desde hace 6 horas. Nació a término, examen físico sin foco aparente, buen estado general, con lactancia activa. ¿Cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Fiebre en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Fiebre: temperatura rectal $> 38^{\circ}\text{C}$; paracetamol 10–15 mg/kg c/6–8h; ibuprofeno > 3 m 5–10 mg/kg c/8h
- < 4 semanas con fiebre: hospitalizar siempre + punción lumbar + hemocultivo + antibióticos empíricos
- 4 semanas–3 meses con buen estado: exámenes (hemograma, PCR, orina), no PL obligatoria si bajo riesgo
- > 3 meses con $T^{\circ} > 39^{\circ}\text{C}$ sin foco: urocultivo obligatorio (ITU es la causa más frecuente de FSF)
- Fiebre sin foco > 6 m: Rx tórax si signos resp; hemocultivo si < 6 m o aspecto tóxico
- Criterios de hospitalización: < 29 días siempre; mal estado general; $T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$ en inmunocomprometido

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIEBRE EN PEDIATRÍA)

PREGUNTA 1

Lactante de 22 días consulta por fiebre de 38.2°C rectal desde hace 6 horas. Nació a término, examen físico sin foco aparente, buen estado general, con lactancia activa. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A)** Alta con paracetamol y control en 24h si no mejora
- B)** Hospitalizar, realizar hemocultivo, urocultivo, PL y comenzar antibióticos empíricos
- C)** Observar en urgencias 2 horas y alta si mejora
- D)** Exámenes ambulatorios y control en 12 horas
- E)** Hospitalizar y antibióticos solo si hemograma muestra leucocitosis

PREGUNTA 2

Niño de 18 meses en buenas condiciones generales, fiebre de 39.8°C de 24 horas sin foco clínico aparente. ¿Qué examen es prioritario solicitar?

- A)** Hemocultivo
- B)** Radiografía de tórax
- C)** Urocultivo (mediante sondeo vesical o punción suprapúbica)
- D)** Punción lumbar
- E)** Ecografía renal

PREGUNTA 3

Niño de 6 semanas con fiebre de 38.5°C. Según criterios de bajo riesgo de Rochester, es catalogado como bajo riesgo (buen estado, sin foco, exámenes en rangos normales). ¿Cuál es la conducta?

- A)** Alta ambulatoria inmediata con paracetamol
- B)** Hospitalizar, observar sin antibióticos con reevaluación frecuente
- C)** Punción lumbar obligatoria y antibióticos independientemente del riesgo
- D)** Alta con amoxicilina oral empírica
- E)** Repetir temperatura en 1 hora y decidir según resultado

RESUMEN: FIEBRE EN PEDIATRÍA

1. Infección urinaria / pielonefritis aguda (la más frecuente) 2. Neumonía bacteriana 3. Meningitis bacteriana aguda 4. Sepsis ::::warning Los AINEs están contraindicados en lactantes < 1 año (riesgo de insuficiencia renal y sangrado gastrointestinal). En > 1 año pueden usarse con precaución. ::::tip Regla práctica: A menor edad, más agresivo el estudio. El RN con fiebre = sepsis hasta demostrar lo contrario → hospitalizar + antibióticos siempre. ::::